

生命維持治療の終了と差し控え

4学会合同ガイドライン2026を、明日のベッドサイドで使う

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

「終末期かどうか」ではなく、手順で決める

多職種の臨床倫理的検討（4観点）と、厚労省プロセスガイドラインに沿ったSDM

2

差し控えと終了は、倫理的に同じ

「やめられないから始めない」をしない。迷えば期限付きの試行（TLT）

3

緩和ケアの準備なしに終了しない

抜管の前に薬と家族の準備を済ませ、苦痛が落ち着くまでそばを離れない

出典：4学会合同GL 本編・説明文・緩和ケア別編（令和8年9月）

架空の場面：この人工呼吸器を、外してよいか



80代男性。誤嚥性肺炎からARDSとなり、挿管して7日目。昇圧薬が続き、意識はまだ戻らない。
長女「父は、管につながれて長く生きるのは嫌だと言っていました」

問1 この人は「終末期」なのか → 第2章

問2 一度つけた人工呼吸器を外してよいか → 第3章

問3 外したら罪に問われないか → 第7章

問4 外すとき、何を準備し、何を使うか → 第4・5章

教育用の架空の症例

本日のお話

1	なぜ改訂したか	「やめられないから始めない」をなくすため
2	誰がどう決めるか	多職種の検討とSDMの2本柱で
3	選択肢は3つ	差し控え・終了・TLT、どれを選んでも苦痛は取る
4	終了の実際	チームでそろえ、止めるものを決め、先回りする
5	症状緩和の薬	先回りし、ボーラスで効かせ、上限を設けない
6	家族と医療者を支える	話し合いの型と、6つの時期のケア
7	記録と法的な位置づけ	経緯を残すことが患者とチームを守る
8	当院での使い方とまとめ	明日のベッドサイドで迷わないために

第 1 章

01

なぜ改訂したか

「やめられないから始めない」をなくすため



旧版の「終末期」が、終了を死の直前まで遅らせた

旧版（2014）の記載	現場で起きたこと	新版（2026）の答え
終末期＝「救命の見込みがないと判断される時期」	生命維持治療で生命が保てる限り終末期にならず、望まない治療が続く	終末期をあえて定義しない
終末期の4つの例示。「近いうち」は2〜3日以内	4つだけが終末期と読まれ、死の直前まで終了できなかった	病態は4観点のうち「医学的側面」として個別に評価する
「緩和的な措置は継続する」の一言	終了後に何をすればよいか分からず、緩和と安楽死の区別も示されなかった	緩和ケア別編を新設。安楽死は違法なので扱わない

出典：説明文、Q&A（Q8）

2つの空白が「やめられないから始めない」を生んだ

空白1：法的リスクの懸念
終了に伴う法的リスクの懸念を
払拭できなかった

空白2：緩和ケアの指針がない
決めた後の緩和ケアの具体的な
指針がなかった

→

「やめられないなら、最初から始めない」
救命できるかもしれない患者の初期治療を、
ためらわせる危険が生まれていた

新版の答え
法的な位置づけを整理し（第7章）、緩和ケア別編で決めた後の手順と薬を示した（第4・5章）

出典：本編、説明文

「中止」でなく「終了」。延命治療・BSCは使わない

用語	扱い	理由
終末期	あえて定義しない	一律の基準では定義できない（Q8）
生命維持治療の中止	「終了」に統一	「中止」は再開もありうると理解される
延命治療・延命措置	使わない	どこからが単なる延命かを区切れない
消極的安楽死	使わない	終了・差し控えは生命の短縮を目的としない
BSC（best supportive care）	使わない	中身が示されず「見放した」と 受け取られやすい

生命維持治療は人工呼吸器だけではない。昇圧薬・ペースメーカー・人工栄養・血液浄化・輸血・輸液も、状況によって含まれる

出典：説明文、本編 注釈1、Q&A（Q7・Q8）

第 2 章

02

誰がどう決めるか

多職種の検討とSDMの2本柱で



きっかけは「苦痛が大きく、望む結果につながらない」

重篤で生命維持治療を要し、その治療が大きな苦痛を伴うのに、患者が望む結果につながらないと考えられるとき
→ チームは最善の治療・ケアのゴールを見直し、その手段として終了・差し控えを考え始める

- 提起するのは誰でもかまわない（Q23）
- 医療者から提案するときは、複数の選択肢と見通しを示し、結論を誘導しない
- 本人が終了を希望しても、本人の希望だけで決めない。医学的妥当性を含む検討とSDMで判断する（Q54）

出典：本編、Q&A（Q23・Q54）

決め方は2本柱：多職種の検討とSDM

柱1　チームの臨床倫理的検討

医療・ケアチームが、医学的側面・患者の意向・QOL・周囲の状況の4観点を、多職種でもれなく話す

柱2　患者・家族等とのSDM

共同意思決定（SDM）。厚労省プロセスガイドラインに沿い、本人の意思の確認状況で4場面に分ける



差し控え

不開始を含む

終了

症状緩和のみ、または一部の終了・減弱

TLT

期限付きの試行。期間を決めて試す

どれでも緩和ケアを並行する。決まらないときは臨床倫理コンサルテーションに助言を求める

出典：本編 I-1・付録3

柱1：4つの観点を、多職種でもれなく話す

医学的側面
診断・予後・治療の有効性と限界

患者の意向
本人の意向 → ACPの記録 → 価値観からの推定

QOL
本人が望む生活・人生の質をどう担保するか

周囲の状況
家族の価値観と介護力、社会的・文化的背景、制度・病院体制

- 関わる全員に公平な発言の機会を保証し、話し合える心理的安全性を確保する
- 医師の方針を追認するだけの形式的な場は、趣旨に反する（Q62）

出典：本編、Q&A（Q22・Q62）

柱2：SDMは、本人の意思の確かめ方で4つに分ける

i. 本人の意思を確認できる	意思決定能力を評価したうえで説明し、合意する。能力がなくても、それまでのACPが今の状況に当てはまれば尊重する
ii. 確認できないが推定できる	家族等とチームが推定した意思を尊重する。ACPの状況が今と違っても、希望や価値観は推定の根拠になる
iii. 推定もできない	家族等と十分に話し合い、本人にとって最善の方針をとる。状態や評価が変わるたびに繰り返す
iv. 身元不詳・身寄りがない	年齢や外見の偏見を排し、過去の意向・価値観を最大限尊重する。終了・差し控えはチームや臨床倫理委員会が公正で透明な手続きで判断する

最善は「本人の価値観に即した最善」。第三者が客観的に決める利益ではない

出典：本編、Q&A（Q46・Q55）

「家族等」は、本人の価値観をよく知る人

- 法的な親族に限らない。親しい友人や事実上のパートナーも含む
- 一人に限らず、複数いてもよい
- 役割は、本人に代わって決めることではない。本人ならどう考えるかを一緒に推し量ること

確かめ方と記録

- 本人が話せるうちに聞く：「話すことが難しくなったら、どなたに意思を推定して話し合ってほしいですか」
- 説明の対象となる家族等とその範囲を記録する
- 推定意思は、誰がどんな根拠でそう考えたかと一緒に記録する
- 家族等に強い決断力を求めず、決定の負担を一人に背負わせない

出典：Q&A（Q5・Q28・Q29・Q50）、本編 III、緩和ケア別編

迷ったら臨床倫理コンサル：助言者で、決定者ではない

相談するとき

- チーム内でゴールが決まらない
- 患者・家族等と合意できない
- 家族の中で意見がまとまらない
- 意思が確認できず、家族もいない

役割

- 決め方がガイドラインに沿っているかを判断して支える。決定を代わりに行うことではない（Q60）
- 適切なプロセスを踏んだ決定であれば、訴追されたときにチームを守る役割を持つとされる
- 医療安全委員会とは別。終了・差し控えは医療事故ではない（Q61）

出典：本編、本編 注釈2、Q&A（Q60・Q61）

第 3 章

03

選択肢は3つ

差し控え・終了・TLT、どれを選んでも苦痛は取る



差し控えと終了は倫理的に同じ、違うのは順序だけ

その治療は、いまの時点で患者にとって適切か（利益が苦痛を上回り、本人の価値観に沿っているか）

差し控え	終了
まだ始めていない → 適切でない	すでに始めている → 適切でない
死亡の原因 病気そのもの。治療をしないことではない	**試した分だけ** 回復の機会があり、差し控えより長く生きられている

終了だけ許されないとすると

予後が読めない急性期に「全部やるか、やらないか」の二択を迫り、救命できたかもしれない治療が差し控えられる

出典：Q&A（Q33・Q34）、緩和ケア別編

3つの選択肢：どれを選んでも、症状緩和は続ける

選択肢	行うこと	行わないこと
差し控える（不開始を含む）	症状緩和の治療とケア。 生命維持装置の設定や昇圧薬は、減弱できれば減弱する	新たな治療の開始と増強。 検査・モニターも最小限に。 心停止時の心肺蘇生
終了：症状緩和だけにする	鎮痛・鎮静薬などは続けて調整する	人工呼吸器・補助循環などの停止を検討（第4章）。心停止時の心肺蘇生
終了：一部を終了・減弱する	項目ごとに、続けるか、減らすか、終えるかを決める	心停止時の心肺蘇生
期限付きの試行（TLT）	合意した期間、特定の治療を試し、目標に向かって改善するかを確かめる	期限が来たら自動的に終了すること

予測と違う経過や意向の変化があれば、もう一度チームで検討し直す

出典：本編 I-2-1、Q&A（Q38）

TLTは3点を先に決め、期限で必ず立ち止まる

① 目標を決める
例：人工呼吸器から離れて会話できる状態に戻る

② 再評価の時点と指標
例：7日目に、離脱の可否と意識レベルで

③ 価値観との結びつき
例：「家族と話せない状態で長く生きることは望まない」

→

期限で立ち止まる

- 改善なら継続・増減を話し合う
- 未達なら終了も含めて見直す

「決めきれないから続ける」にしない
期限が来ても自動で終了せず、自動で延長もしない。3点が曖昧なまま続けると、先送りになる

出典：本編、Q&A（Q35・Q36）。例の文言は記録の書き方の一例

DNARで決まるのは、心停止時の蘇生だけ

DNARは「心停止時に心肺蘇生を行わない」という限定的な指示。対象は胸骨圧迫・除細動・気管挿管などの心停止時の処置に限られる

DNARがあっても行うこと

- 肺炎への抗菌薬
- 呼吸困難への酸素・非侵襲的換気
- 痛みや不安への鎮痛・鎮静
- 脱水への補液

してはいけないDNARの運用

- 入院時に一律に設定する
- 業務効率や急変対応の簡略化のために設定する
- partial DNAR（胸骨圧迫はするが挿管はしない等）の曖昧な指示

出典：Q&A（Q37・Q39）

強心薬も人工栄養も、何のために使っているかで決める

治療	考え方
心不全の苦痛緩和に使っていた強心薬（Q40）	症状の強さと必要性に応じて増減する。必ずしも減量や終了は要らない
ペースメーカー（Q41）	自己脈がほとんどなく依存しているなら、事実上の生命維持治療。依存の程度で個別に判断
機械的補助循環（Q42）	対象に含まれ、同じ手順で決める。日本では議論が乏しく、経験施設が非常に少ない
自発呼吸のない患者の抜管（Q43）	ありうる。心停止までが短くなるのが一般的で、事前に家族へ十分に説明する
人工栄養（Q44）	胃ろうを含め生命維持治療の一つ。行わない場合も口腔ケア・食事介助・苦痛緩和は続け、「何もしない」ではない

出典：Q&A（Q40〜Q44）

第 4 章

04

終了の実際

チームでそろえ、止めるものを決め、先回りする



始める前に、チームで5つの共通認識をそろえる

1. 生命維持治療は、最善のゴールを達成する選択肢として終了・差し控えできる
2. 終了・差し控えには、適切なプロセスを踏む必要がある
3. ガイドラインに沿った終了・差し控えは安楽死とは異なり、法的に問題となる行為ではない
4. 症状緩和が最優先で、適切に薬を使った結果、間接的に死期が早まりうることは許容される
5. 終了・差し控えは、患者を見捨てることではない

あわせて確認：心停止時に胸骨圧迫を含む蘇生を行わない。抜管後に再挿管しない

出典：緩和ケア別編

止めるものと、止めるかを検討するものを分ける

区分	項目	注意点
終了する	透析、経管栄養、昇圧薬、抗菌薬、 輸血、筋弛緩薬、身体拘束	家族等と十分に話して決める
検討：装置	機械的循環補助、ペースメーカー、 ICDの除細動機能	ICDは循環器内科医と相談して 除細動機能の停止を検討
検討：ライン・ モニター	中心静脈ライン、動脈ライン、 心電図モニター、パルスオキシメーター	中心静脈は、末梢がなければ投与路として残してよい。モニターを 付けるならアラームを切る
検討：ケア・検査	バイタルサインの測定、輸液、 体位変換、血液検査、X線・CT	輸液は浮腫・腹水・胸水・せん妄につながるので、終了を検討する

観るのは数値ではなく、表情と家族の反応

出典：緩和ケア別編

抜管の前日から、時間を逆算して準備する

24時間前	**経管栄養を止める**	24時間前までに終えておくのが望ましい
12時間前	**上気道浮腫のハイリスクなら**	メチルプレドニゾロン20 mgを4時間おきに静注（カフリークテストで評価）
2時間前	**筋弛緩薬を止める**	多臓器不全では18時間前
30分前	**分泌物が予想されるなら**	ブチルスコポラミン10〜20 mg皮下注を選択肢に
5分前	**苦痛を先回り**	オピオイドと鎮静薬の事前投与を検討（第5章）
抜管後	**医師・看護師は離れない**	苦痛が落ち着くまで、そばで調整する

濃いティールは全員が対象。12時間前・30分前・5分前は、必要な患者に

出典：緩和ケア別編（本文・表1・表2）

抜管は、段階的離脱か即時抜管を選ぶ

段階的離脱
gradual weaning

- 15〜30分かけて呼吸器の設定を下げ、できるだけ自発呼吸へ移してから抜管する
- 高度のサポートが必要な呼吸不全で多い

即時抜管
immediate extubation

- 設定を下げずに、鎮静・鎮痛の準備を済ませてから抜管する
- 脳神経疾患などで意識障害がある患者で多い

0.9時間

抜管から死亡までの中央値（海外の報告）。
数時間〜数日の例もある

15〜30分

段階的離脱で、設定を下げる時間

出典：緩和ケア別編、Q&A（Q43）

家族には、経過・支え・別れの時間を先に用意する

経過を伝える
終了後に呼吸や循環がどう変わるかを具体的に説明し、心の準備を促す

支える
看護師（可能なら心理職やソーシャルワーカー）が心理的に支える

別れの時間
別れを告げ、思い出を振り返る時間と環境を確保する

- 立ち会いを望まない家族には一度退室してもらい、苦痛が抑えられたことを確かめてから、すぐに入室してもらう

- 気道狭窄や喘鳴が出たら対応すること、ケアは続くことも先に伝えておく

出典：緩和ケア別編

第 5 章

05

症状緩和の薬

先回りし、ボーラスで効かせ、上限を設けない



緩和ケアの準備なしに、終了しない

適切な緩和ケアを提供できない状態で、終了・差し控えを行うべきではない

- 緩和ケアは終了の後ではなく、救急搬送・ICU入室の早期から始める
- 主治医や担当看護師が日常の診療として「基本的緩和ケア」を行い、難しければ緩和ケアの専門家と連携する
- 救命治療と苦痛の軽減は対立せず、両輪（Q57・Q58）
- 苦痛の評価：答えられればESAS-r-J・IPOS患者評価用、答えられなければIPOSスタッフ評価用

出典：本編、説明文、Q&A（Q57・Q58）、緩和ケア別編

薬の原則は4つ：必要十分・定期評価・柔軟・上限なし

必要十分

過少投与で苦痛を残すことも、過量投与で過度に鎮静することも避ける

定期評価

定期的に評価して調整する。深い鎮静でも苦痛の評価を怠らない

柔軟

予想に反して長く生存したら、減量も含めて見直す

オピオイドに上限なし

効果がある限り、症状が緩和されるまで増やす。効果がなければ増やさず、鎮静薬などを考える

終了時の症状コントロールは質の高いエビデンスが乏しく、経験と専門家の合意に基づく。用量は一例で、体重・年齢・病状・臓器障害で調整する

出典：緩和ケア別編

初回量の目安：まず少量をボーラスで、効くまで刻む

症状	薬	初回	追加・続け方
呼吸困難・痛み（オピオイド未投与）	モルヒネ	2〜5 mg 静注／皮下	10〜15分ごとに1〜2時間量を早送り。持続は5〜10 mg/日から
同上	フェンタニル	20〜50 µg 静注／皮下	5〜10分ごとに0.35〜0.5 µg/kgを反復
不安	ミダゾラム	0.01〜0.06 mg/kg を1分以上かけて	5分以上あけて0.03 mg/kgを追加。総量0.3 mg/kgまで
せん妄	ハロペリドール	2.5〜5 mg	10 mg/日まで
気道分泌物	ブチルスコポラミン	20 mg 皮下／筋注	1日数回、または20〜60 mg/日を持続

オピオイド未投与ならモルヒネ2〜5 mgのボーラスから。高齢で衰弱した人ではさらに少なく

出典：緩和ケア別編 表1（米国救急医学レジデント協会の実務記事を改変）。用量は一例

持続投与中なら、抜管直前に直近量に比例して上乗せ

持続投与中　持続投与なし

持続投与中

抜管直前 → 抜管後

モルヒネ	直近の効果量の2倍をボーラス → 10〜15分ごとに追加ボーラス
フェンタニル	直近1時間量の25〜50%をボーラス → 5〜10分ごとに追加ボーラス
ミダゾラム	持続の1時間量をボーラス → 直近の0.5〜1時間量を5〜10分ごとに追加

持続投与なし（例）

抜管直前 → 抜管後

モルヒネ	5分前に5 mg → 10分ごとに呼吸困難・痛みに応じて追加
フェンタニル	5分前に25〜100 µg → 5〜10分ごとに50〜100 µgを追加
ミダゾラム	5分前に2〜4 mg → 5〜10分ごとに不安・呼吸困難に応じて2〜4 mgを追加

苦痛が十分に緩和されたと確認できるまで、医師と看護師はベッドサイドを離れない

出典：緩和ケア別編 表2（死亡までが短い、または直後に苦痛が出ると予想されるとき）

症状ごとの初手と、しないこと

症状ごとの初手

呼吸困難・痛み	オピオイドをボーラスで。不十分なら追加か持続を足す
不安	ミダゾラム（効きが早く短い）
過活動型せん妄	抗精神病薬（またはベンゾジアゼピン）。非薬物的な対処も
気道分泌物（死前喘鳴）	体位の工夫と輸液の減量。抗コリン薬は選択肢
上気道の狭窄	抜管前にカフリークテスト。ハイリスクなら予防的ステロイドか、チューブを残す

しないこと

不安・せん妄にオピオイド
鎮静目的のオピオイドは推奨されない

深い吸引
出血や咽頭反射を誘発する。口腔内など浅い部分を愛護的に

筋弛緩薬を残す
苦痛を評価できず、鎮痛を調整できない

出典：緩和ケア別編

話せない患者の呼吸困難は、RDOSで補って評価する

項目	0点	1点	2点
心拍数（回/分）	89以下	90〜109	110以上
呼吸回数（回/分）	18以下	19〜30	31以上
落ち着きのなさ（合目的でない動き）	無	時々軽微な動き	頻繁な動き
奇異呼吸（吸気時に腹部が陥没）	無	—	有
呼吸補助筋の使用（肩呼吸）	無	わずかに上昇	著しく上昇
呼気終末の呻吟	無	—	有
鼻翼呼吸	無	—	有
苦悶表情（2点はどれか1つ）	無	—	目を見開く・顔面の緊張・眉間の皺・開口・歯を食いしばる

出典：緩和ケア別編 表3（Sakuramoto, PLoS One 2021 の日本語版）。成人用。筋弛緩薬で麻痺している患者には使えない

症状緩和と安楽死を分けるのは、目的と量

症状緩和（ガイドラインの範囲）

- 苦痛を取るのに必要十分な量に調整する
- 適切に薬を使った結果、間接的に死期が早まりうることは許容される
- 終了・差し控えは、病の自然な経過を受け入れる判断で、生命の短縮を目的としない

安楽死（扱わない）

- 死亡を目的に過量投与すれば、安楽死で違法（Q59）
- 安楽死は現在の日本では違法となるため、本ガイドラインでは扱わない
- 有罪の2件は、塩化カリウムや筋弛緩薬で死期を早めた（第7章）

だから「消極的安楽死」とは呼ばない。量は記録し、なぜその量かを説明できるようにする

出典：本編、説明文、Q&A（Q59）、緩和ケア別編

第 6 章

06

家族と医療者を支える

話し合いの型と、6つの時期のケア



話し合いは「聴く」から始め、推奨は最後に

1 始める	目的を伝え、許可を得る
2 理解と心配を聴く	「今一番心配になられていることはどのようなことですか？」
3 見通しを伝える	不確実さと、難しいことははっきりと
4 大切なことを聴く	「あなたにとってとても大切で、これができないまま生きていくのは考えられない、と思うのはどんなことですか？」
5 推奨して締める	「〇〇がとても大切だとおっしゃいましたね。それを考慮に入れると、現在の病状では◎◎をお勧めします」

医療側が一方的に説明を始めない。聴いた本人の言葉を引用して、推奨につなげる

出典：緩和ケア別編 第1章

家族のケアは、決める前から死別後まで6つの時期で

1 話し合いの前

家族の全体像をつかむ

患者の人となりを聞く。
休める場を用意

2 話し合いの間

寄り添い、補う

理解のずれは否定せず、
実際の様子を見てもらう

3 話し合いの後

揺れを支える

迷いは当然と伝え、
保清を一緒に

4 終了前

起こる変化を伝える

数分〜数日と幅が
あると説明

5 臨終時

時間と環境を守る

音・におい・汚れを
整え、死後の処置への
参加を尋ねる

6 死別後

つながりを残す

パンフレット、1〜2週後の
電話を検討

出典：緩和ケア別編 V

医療者のモラルディストレスは、組織で支える

モラルディストレスとは
正しいと信じることが、他者の価値観や組織の制約で実行できないときの不満・怒り・失望。
特に看護師が経験しやすい

組織として用意するもの

- 適切な人員配置と仕事量の管理
- 困難な事例の後のデブリーフィング
- スタッフの心理状態の定期的なスクリーニング（MMD-HPなど）
- 緩和ケアチーム・倫理委員会・相談窓口と連携した相談の体制

出典：緩和ケア別編 VI

第 7 章

07

記録と法的な位置づけ

経緯を残すことが患者とチームを守る



有罪になった2件は、死期を早める薬を使っていた

事件	何をしたか	司法判断
東海大学病院事件（1991）	点滴などを外し、ジアゼパムの後、ベラパミルと塩化カリウムを静注	1995年 横浜地裁で殺人罪
川崎協同病院事件（1998）	抜管し、苦悶様呼吸に鎮静薬、さらに筋弛緩薬を投与	2009年 最高裁が上告を棄却し有罪が確定
射水市民病院事件（2000〜2005）	終末期のがん等の患者7名の人工呼吸器を外した	2009年 不起訴
道立羽幌病院事件（2004）	本人の意思を確認せず、家族への説明も不十分なまま人工呼吸器を外した	因果関係が認められないとして不起訴

分かれ目は、意図的に死期を早めたかどうか

出典：説明文

法的な拠り所は手順と記録。ただし免責ではない

報道された事件はない	2007年以降、救急・集中治療の終末期医療で、刑事事件や警察の介入が全国的に報道された例は確認されていない（説明文）
適切なプロセスなら	ガイドラインに沿って適切に行われた終了・差し控えが、同意殺人罪や自殺幇助罪にあたることはないと考えられる（Q48・Q52）
免責ではない	ガイドラインは法的な強制力のない規範（soft law）。従えば法的に免責されるとは書いていない。即さない形で行えば、批判に耐えられない可能性がある

このガイドラインは「治療を止める基準」ではない。障がいや医療資源を理由に終了を広げるものでもない

出典：説明文、Q&A（Q48・Q52・Q47・Q70〜Q77）

記録は「説明・本人の意思・検討の経緯」の3群

区分	記載する事項
医学的な検討とその説明	① 説明の対象となる患者・家族等とその範囲　② 説明した内容 ③ 理解や受容の状況　④ 同席した医療・ケア従事者
患者の意思	① 本人の意思、またはACPの記録などに示された意思と、それが述べられた状況 ② それがない・不明なら、家族等による推定意思とその根拠
終了・差し控えを検討する際の対応	① 本人の意思またはACPの内容　② 家族等による推定意思とその根拠 ③ 家族等の意向　④ 終了・差し控えを考慮する時期であることとその根拠 ⑤ 最善のゴールについての検討内容　⑥ 検討に加わったすべてのメンバー

出典：本編 III、Q&A（Q15）

「BSC」と書かず、続ける・控える・終えるを書く

× 書かない

「BSCの方針」

「以後は緩和の方針」

中身が見えず、「もう治療はしない」「見放した」と受け取られやすい

○ 書く（記録の文例）

ゴール	残された時間を苦痛なく家族と過ごす
続ける	フェンタニル持続と必要時のボーラス、ミダゾラム、口腔ケア
始めない・増やさない	昇圧薬の増量、新たな血液浄化。検査は最小限
終える	人工呼吸器（〇日〇時に抜管予定）、経管栄養（抜管24時間前に終了）、抗菌薬
心停止時	心肺蘇生は行わない
苦痛の評価	表情・呼吸回数・RDOSを〇時間ごと

出典：説明文、本編 注釈3・I-2-1、Q&A（Q37）。文例は項目に沿って作った例で、原典の文言ではない

第 8 章

08

当院での使い方とまとめ

明日のベッドサイドで迷わないために



当院では3ステージで価値観を聴き、迷ったら声を上げる

3ステージプロトコル（当院ICUの共通言語）

Stage 1	病状の説明
Stage 2	治療ゴールの設定
Stage 3	治療オプションの相談

Stage 2を飛ばさない。GLの「大切なことを聴く」質問は、Stage 2の質問とほぼ同じ

迷ったら声を上げる

- ERRS（倫理版RRS）で、もやもやを言語化して声を上げる
- その先が臨床倫理コンサル
- 記録の型（ICテンプレート）は3ステージに沿う形へ改訂中

30% 倫理コンサルの活用方法を知っているICUスタッフ

出典：聖路加ICU 意思決定支援・倫理の取り組み、ICU倫理係アンケート（2026年6月・37名）

冒頭の場面に戻る：4つの問いへの答え

問1　**この人は「終末期」なのか**

終末期かどうかは決めない。4観点の検討とSDMで、本人の価値観に沿う対応を選ぶ

問2　**一度つけた人工呼吸器を外してよいか**

差し控えと終了は倫理的に同じ。差し控え・終了・TLTの3つから選ぶ

問3　**外したら罪に問われないか**

適切なプロセスと記録なら違法とされないと考えられる。ただし免責ではない

問4　**外すとき、何を準備し、何を使うか**

経管栄養24時間前・筋弛緩薬2時間前に止め、薬を先回りし、そばを離れない

明日からの3つ

1

方針は「BSC」と書かない
ゴールと、続ける・始めない・終える治療を、項目ごとに書く

2

TLTは3点を書いてから始める
目標・再評価の時点と指標・価値観との結びつき。期限で必ず立ち止まる

3

抜管は前日から逆算する
経管栄養24時間前・筋弛緩薬2時間前に止め、薬を先回りし、そばを離れない

確認クイズ：◯か×か

Q1 DNARの患者には、肺炎への抗菌薬を始めない

Q2 一度始めた人工呼吸器の終了は、差し控えより倫理的に重い

Q3 「家族等」は、法的な親族に限られる

Q4 筋弛緩薬は、抜管の2時間前までに止める

Q5 抜管後の苦痛に使うオピオイドには、上限量を決めておく

Q6 ガイドラインに従えば、法的に免責される

確認クイズの答え

Q1 ✕ DNARで決まるのは心停止時の蘇生だけ（Q37）

Q2 ✕ 差し控えと終了は倫理的に同じ（Q33）

Q3 ✕ 本人の価値観をよく知る人。友人やパートナーも（Q5）

Q4 ◯ 多臓器不全では18時間前まで（緩和ケア別編）

Q5 ✕ オピオイドには用量の上限を設けない（緩和ケア別編）

Q6 ✕ 違法とされないと考えられるが、免責とは書いていない

出典：4学会合同GL 本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編（令和8年9月）



ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（4学会合同ガイドライン）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科